



EDITORA AGÊNTICA

# O DENTISTA QUE VIROU GESTOR & OS NÚMEROS DA CLÍNICA: FLUXO DE CAIXA, TICKET MÉDIO E CUSTOS

O Dentista Gestor: do fim de expediente ao comando da clínica

PARA INICIANTES

**Heverton Eduardo Peres**

ESPECIALISTA EM MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

**Heverton Eduardo Peres**

# **O Dentista que Virou Gestor & Os Números da Clínica: Fluxo de Caixa, Ticket Médio e Custos**

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

Brasil  
2026

## Sumário

---

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| O Dentista que Virou Gestor & Os Números da Clínica: Fluxo de Caixa, Ticket Médio e Custos ..... | 6  |
| Como Este Livro Foi Escrito: A Metodologia EITA .....                                            | 7  |
| As 7 Seções do EITA .....                                                                        | 7  |
| 1. INTRODUÇÃO .....                                                                              | 7  |
| 2. EXPLICA .....                                                                                 | 7  |
| 3. ILUSTRA .....                                                                                 | 7  |
| 4. TÉCNICA .....                                                                                 | 7  |
| 5. APLICA .....                                                                                  | 8  |
| 6. CONCLUSÃO .....                                                                               | 8  |
| 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                                              | 8  |
| Por Que Funciona .....                                                                           | 8  |
| Diagrama do Fluxo EITA .....                                                                     | 8  |
| Dica de Leitura .....                                                                            | 9  |
| Capítulo 1: O Dentista que Virou Gestor .....                                                    | 10 |
| 1. Introdução .....                                                                              | 10 |
| 2. Explica .....                                                                                 | 11 |
| O problema estrutural: formado para clinicar, não para gerir .....                               | 11 |
| A escala do problema: custos e mortalidade .....                                                 | 11 |
| Os números que importam na odontologia .....                                                     | 12 |
| Por que a IA gratuita muda o jogo .....                                                          | 12 |
| As regras do jogo: conformidade e privacidade .....                                              | 12 |
| 3. Ilustra .....                                                                                 | 13 |
| 4. Técnica .....                                                                                 | 14 |
| O primeiro controle: a planilha do caixa da clínica .....                                        | 14 |
| Pedindo a planilha ao assistente .....                                                           | 14 |
| Automatizando com Python sem instalar nada .....                                                 | 15 |
| Classificando despesas com regras (e conferindo com a IA) .....                                  | 15 |
| O retrato da sazonalidade do consultório .....                                                   | 16 |
| A projeção simples de caixa (90 dias) .....                                                      | 16 |
| A pergunta de calibração .....                                                                   | 16 |
| Montando a rotina do fim de expediente .....                                                     | 17 |
| Estruturando sua pasta de trabalho .....                                                         | 17 |
| O retrato do investimento inicial .....                                                          | 17 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| O exemplo do pró-labore na prática .....                                        | 18 |
| A pergunta de investigação de gasto .....                                       | 18 |
| O exemplo da projeção de 90 dias .....                                          | 18 |
| A frase que resume o capítulo .....                                             | 19 |
| O convite para o próximo expediente .....                                       | 19 |
| Kit de verificação do primeiro dia .....                                        | 19 |
| 5. Aplica .....                                                                 | 19 |
| A cena do caos .....                                                            | 19 |
| A mesma cena, com o método .....                                                | 20 |
| Exercício do fim de expediente .....                                            | 20 |
| O exercício corrige o rumo .....                                                | 20 |
| 6. Conclusão .....                                                              | 20 |
| 7. Referências .....                                                            | 21 |
| Capítulo 2: Os Números da Clínica — Fluxo de Caixa, Ticket Médio e Custos ..... | 23 |
| 1. Introdução .....                                                             | 23 |
| 2. Explica .....                                                                | 23 |
| O fluxo de caixa: o pulso diário .....                                          | 23 |
| O capital de giro: o colchão da clínica .....                                   | 24 |
| O DRE simplificado: a radiografia mensal .....                                  | 24 |
| O ticket médio: o termômetro do valor .....                                     | 25 |
| O custo da cadeira e a depreciação .....                                        | 25 |
| O pró-labore e a separação das contas .....                                     | 25 |
| O contexto externo: juros, inflação e o mercado de serviços .....               | 26 |
| A disciplina da apuração mensal .....                                           | 26 |
| 3. Ilustra .....                                                                | 26 |
| 4. Técnica .....                                                                | 27 |
| Montando o DRE simplificado na planilha .....                                   | 27 |
| Automatizando a apuração com Python .....                                       | 27 |
| Cruzando com referências oficiais .....                                         | 28 |
| A planilha de custos da cadeira .....                                           | 28 |
| A análise de sensibilidade: o que acontece se... ..                             | 29 |
| O benchmark com o setor de serviços .....                                       | 29 |
| A tabela de referência do setor .....                                           | 30 |
| O DRE de exemplo, número por número .....                                       | 30 |
| As perguntas que o DRE responde (e as que ele não responde) .....               | 30 |
| A leitura de tendência: três meses valem mais que um .....                      | 31 |
| Precificando com o custo na mão .....                                           | 31 |
| O que evitar no prontuário financeiro .....                                     | 32 |
| A memória de doze meses .....                                                   | 32 |
| Kit de verificação do capítulo .....                                            | 32 |
| 5. Aplica .....                                                                 | 32 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A cena do caos .....                     | 32 |
| A mesma cena, com o método .....         | 33 |
| Exercício do prontuário financeiro ..... | 33 |
| O exercício corrige o rumo .....         | 33 |
| 6. Conclusão .....                       | 33 |
| 7. Referências .....                     | 34 |
| Seu próximo passo .....                  | 35 |

## **O Dentista que Virou Gestor & Os Números da Clínica: Fluxo de Caixa, Ticket Médio e Custos**

---

## Como Este Livro Foi Escrito: A Metodologia EITA

---

Todo capítulo deste livro segue a metodologia **EITA** — um framework pedagógico de 7 seções projetado para transformar o leitor de “não sei” para “consigo fazer” em cada tema abordado.

### As 7 Seções do EITA

---

#### 1. INTRODUÇÃO

Contextualiza o tema. Explica o que será abordado, por que importa, e o que você será capaz ao final. Uma ponte conecta com o capítulo anterior (quando houver).

#### 2. EXPLICA

Desconstrói o conceito: causa raiz, mecânica subjacente, definições precisas. Você passa de “não sei o que é” para “sei definir e explicar”.

#### 3. ILUSTRA

Uma analogia concreta ancora o conceito na sua intuição — sempre acompanhada de um diagrama visual que torna o abstrato tangível. Você passa de “parece abstrato” para “faz sentido”.

#### 4. TÉCNICA

O núcleo de valor: código executável, arquiteturas, passo a passo de implementação. É aqui que você ganha as mãos para fazer. Você passa de “não sei fazer” para “consigo implementar”.

## 5. APLICA

Contextualização em cenário real: onde aquilo se aplica no mercado, armadilhas comuns e como evitá-las. Você passa de “isso é teórico” para “vou usar no trabalho”.

## 6. CONCLUSÃO

Síntese dos 3 pontos principais, conexão com o próximo capítulo e um desafio opcional para fixar o aprendizado.

## 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fontes citadas no capítulo, em formato ABNT numerado. Toda afirmação factual tem sua referência.

## Por Que Funciona

O EITA não é uma lista de tópicos — é uma **jornada de transformação**. Cada seção leva o leitor a um estado mental diferente:

Introdução → "Quero aprender"  
Explica → "Entendi a teoria"  
Ilustra → "Faz sentido na prática"  
Técnica → "Consigo fazer"  
Aplica → "Vou usar no trabalho"  
Conclusão → "Dominei este tema"

## Diagrama do Fluxo EITA

```
%% legenda: Fluxo de aprendizado das 7 seções EITA
flowchart LR
    A[Introdução] --> B[Explica]
    B --> C[Ilustra]
    C --> D[Técnica]
    D --> E[Aplica]
    E --> F[Conclusão]
    F --> G[Referências]
```



## Dica de Leitura

---

Você pode ler os capítulos em ordem (recomendado para iniciantes) ou pular diretamente para o tema de interesse. Cada capítulo é autocontido, mas a sequência cria conexões que ampliam o aprendizado.

---

*A metodologia EITA é uma criação da Fábrica Agêntica de Livros, projetada para produzir literatura técnica que transforma leitores em profissionais.*

## Capítulo 1: O Dentista que Virou Gestor

---

### 1. Introdução

---

Você terminou a última consulta do dia, tirou o jaleco e pendurou no cabide. A recepção está vazia, a auxiliar foi embora e a clínica fica em silêncio. É nesse momento — o fim de expediente — que a maioria dos dentistas enfrenta a pergunta que nenhuma faculdade preparou para responder: quanto a clínica realmente ganhou hoje? Quanto custa abrir a cadeira pela manhã? O dinheiro que sobrou no caixa é lucro ou é a sua fatura do cartão que ainda não caiu?

Este livro nasce dessa pergunta. O cirurgião-dentista é um dos profissionais mais bem formados do mundo para cuidar da saúde bucal e, ao mesmo tempo, um dos menos preparados para cuidar do próprio negócio. A grade da graduação em Odontologia quase não reserva espaço para empreendedorismo e gestão financeira, e o resultado aparece nas estatísticas: uma parcela significativa das clínicas abre e fecha as portas nos primeiros anos de operação, não por falta de pacientes, mas por falta de controle financeiro [1]. Neste capítulo, você vai entender por que isso acontece, qual é o custo real de uma clínica e por que a IA gratuita — a mesma que cabe no bolso de qualquer celular — pode ser a virada de mesa para o dentista que decide virar gestor.

Ao final deste capítulo, você será capaz de explicar, em uma conversa de corredor, o tripé que sustenta uma clínica saudável: o dinheiro da clínica separado do seu dinheiro (pró-labore), os números na mesa todos os dias (fluxo de caixa) e a decisão baseada em dado, não em sensação. Você também vai conhecer o colega de bancada que vamos usar em todo o livro: a inteligência artificial gratuita, que vai ajudar a montar planilhas, calcular indicadores e organizar o caos financeiro do consultório.

## 2. Explica

---

### O problema estrutural: formado para clinicar, não para gerir

A formação odontológica é técnica e clínica: anatomia, patologia, materiais, cirurgia, periodontia. O que o curso não ensina é o que acontece depois que o paciente paga a consulta — ou não paga. Estudos acadêmicos sobre a administração de consultórios mostram que a ausência de disciplinas de empreendedorismo na graduação faz com que o dentista negligencie a gestão financeira justamente no momento em que ela mais importa: a abertura do negócio [1]. O resultado é uma rotina conhecida no setor: o profissional trata bem, fideliza pacientes, mas não sabe dizer se está lucrando, porque nunca estruturou um controle de despesas, um fluxo de caixa ou uma previsão de capital de giro [2].

Isso não é falta de inteligência — é falta de ferramenta. A boa notícia é que os processos de administração financeira aplicados a consultórios já estão mapeados e validados na literatura especializada: separação das finanças pessoais das da clínica, controle sistemático de contas a pagar e a receber, apuração mensal do resultado e cálculo da necessidade de capital de giro [2]. O que falta é uma forma acessível de colocar isso em prática — e é exatamente aí que a IA gratuita entra.

### A escala do problema: custos e mortalidade

Montar uma clínica exige capital. Os equipamentos essenciais têm preços de referência bem conhecidos no mercado brasileiro: uma cadeira odontológica parte de cerca de R\$ 22.650, uma autoclave custa a partir de R\$ 6.200 e um compressor odontológico sai por volta de R\$ 2.700 [3]. Somando mobiliário, instalações, materiais e adequação sanitária, o investimento inicial de um consultório básico fica entre R\$ 40 mil e R\$ 100 mil — e esse dinheiro precisa ser recuperado pelo fluxo de caixa da operação [3]. É por isso que o custo unitário por sessão é uma conta que todo dentista deveria saber fazer antes de precificar qualquer procedimento [4].

O quadro se agrava quando o consultório cresce: cada cadeira adicional multiplica custos fixos (aluguel, energia, salários, esterilização), e a margem de cada procedimento precisa absorver essa estrutura. A literatura recomenda que os custos fixos fiquem entre 40% e 50% do faturamento bruto [5]. Acima disso, a clínica começa a operar no vermelho mesmo com agenda cheia — um dos fenômenos mais frustrantes do setor, em que o profissional trabalha cada vez mais e ganha cada vez menos.

## Os números que importam na odontologia

Existe um conjunto pequeno de indicadores que resume a saúde financeira de uma clínica. O primeiro é o **ticket médio**: o faturamento total dividido pelo número de pacientes atendidos em um período [6][7]. Se o seu ticket médio é baixo, a clínica está faturando com procedimentos de baixo valor agregado ou concedendo descontos excessivos; se é alto, os tratamentos de alto valor estão puxando a receita [6]. O segundo é a **margem de lucro líquida**: clínicas odontológicas eficientes operam com margens entre 20% e 35%, e os desvios vêm, quase sempre, de precificação errada ou de descontos e parcelamentos longos que corroem o rendimento real [8]. O terceiro é a **inadimplência**: o indicador deve ficar abaixo de 5%; taxas acima de 10% exigem ação imediata de cobrança e revisão da política de parcelamento [5].

Há ainda dois conceitos de gestão que a literatura do setor repete: o **pró-labore** e o **capital de giro**. O pró-labore é o salário que o dentista se paga como funcionário da própria clínica — a separação rígida entre o dinheiro da empresa e o dinheiro da família, apontada como a primeira regra da saúde financeira do consultório [9]. O capital de giro é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante operacional de curto prazo: é o colchão que paga as contas enquanto os parcelamentos dos pacientes não entram no caixa [10]. Uma clínica sem capital de giro é uma clínica que depende do próximo recebimento para respirar — e um atraso de dois meses de um plano odontológico pode derrubar o caixa.

## Por que a IA gratuita muda o jogo

A gestão financeira do consultório é feita de tarefas repetitivas e padronizáveis: registrar recebimentos, classificar despesas, montar o fluxo de caixa mensal, calcular o ticket médio, projetar o caixa dos próximos 90 dias. Tudo isso pode ser feito em planilhas — e tudo isso pode ser feito **com a ajuda de um assistente de IA gratuito** que escreve as fórmulas, explica os cálculos e corrige os erros no lugar do dentista.

A IA não substitui a decisão do gestor: ela acelera o trabalho braçal e coloca os números na mesa. E o setor odontológico tem uma característica que torna essa combinação ainda mais poderosa: os dados financeiros de uma clínica são relativamente simples (algumas centenas de lançamentos por mês), cabem em uma planilha e seguem padrões de mercado bem documentados [5][8]. Ou seja, a matéria-prima existe, a ferramenta gratuita existe e o método existe — falta apenas o gestor decidir usar.

## As regras do jogo: conformidade e privacidade

Antes de colocar os dados da clínica em qualquer ferramenta, o dentista precisa conhecer as regras. A clínica é um estabelecimento de saúde: o cadastro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é obrigatório para o funcionamento regular [11], e os dados dos pacientes — incluindo prontuários, fotos e informações de pagamento — são dados pessoais

sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) [12]. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) regula o tratamento desses dados e o uso de IA, com regras específicas para agentes de pequeno porte [13]. A profissão, por sua vez, é disciplinada por normas do Conselho Federal de Odontologia, que também regulam a publicidade e a forma de anunciar valores [14]. Para dimensionar o mercado em que a clínica opera, o gestor pode recorrer à Pesquisa Nacional de Saúde, que monitora o acesso da população aos serviços de saúde no país [15]. Na prática, isso significa uma regra simples que vamos repetir em todo o livro: **dados de pacientes nunca sobem para a nuvem sem anonimização**. Quando precisar de um modelo de IA, o dentista anonimiza o dado antes — e, para dados ainda mais sensíveis, existem os modelos locais que rodam sem sair do computador.

### 3. Ilustra

Imagine o fim de expediente de uma clínica de sucesso — não a que você imagina, mas a que você vai construir com este livro. O dentista não está mais no corredor olhando a agenda do dia seguinte. Ele está sentado à bancada, diante de uma tela com três janelas abertas: a planilha de fluxo de caixa, o chat de IA e o dashboard de indicadores. Ele não está trabalhando mais: está **examinando o prontuário financeiro da clínica**, com o mesmo cuidado com que examina um dente — procurando cáries de caixa, fissuras de margem e infecções de inadimplência.

Como Gestor de Clínica Odontológica, você vai perceber que a clínica tem dois pacientes: o paciente que senta na cadeira e o paciente que é o próprio negócio. O diagrama abaixo mostra como o dinheiro flui pela clínica — e onde a IA gratuita se encaixa para dar visibilidade a cada etapa.

```
%% legenda: Fluxo financeiro da clinica odontologica com IA gratuita
flowchart LR
    A[Consulta e tratamento] --> B[Faturamento]
    B --> C[Caixa da clinica]
    C --> D{Fluxo de caixa na planilha}
    D -->|recebimentos| E[Contas a pagar]
    D -->|entradas| F[Ticket medio e receita]
    E --> G[Dashboard de KPIs]
    F --> G
    G --> H{Dentista gestor}
    H -->|conferencia| I[Decisao]
    I --> J[Pro-labore e reinvestimento]
    I -. ->|IA gratuita ajuda a montar tudo| D
```

## 4. Técnica

### O primeiro controle: a planilha do caixa da clínica

Você não precisa de software caro para começar. O primeiro artefato de gestão da sua clínica é uma planilha de fluxo de caixa — e ela pode ser montada em minutos com a ajuda de um assistente de IA gratuito. O método é sempre o mesmo: você descreve o que quer em linguagem natural, o assistente devolve a estrutura e as fórmulas, e você confere o resultado.

Comece criando um arquivo CSV com os lançamentos do mês. Você pode criar esse arquivo no Bloco de Notas, salvando com o nome `caixa_clinica.csv`:

```
Data,Descricao,Categoria,Entrada,Saida
2026-01-05,Consulta limpeza,Procedimento,250.00,
2026-01-08,Restauracao,Procedimento,350.00,
2026-01-10,Compra material,Suprimento,,180.00
2026-01-12,Aluguel,Custo fixo,,3200.00
2026-01-15,Plano odontologico repasse,Plano,4200.00,
2026-01-20,Auxiliar salario,Pessoal,,2400.00
2026-01-25,Implantoproteses,Procedimento,4800.00,
2026-01-28,Conta de energia,Custo fixo,,620.00
2026-01-30,Autoclave manutencao,Equipamento,,450.00
```

### Pedindo a planilha ao assistente

Abra o chat do assistente gratuito de sua preferência (ChatGPT, Gemini ou Copilot) e cole este prompt:

```
Atue como um consultor financeiro de clinicas odontologicas.
Vou colar abaixo os lancamentos do fluxo de caixa da minha clinica.
1. Calcule o total de entradas e o total de saidas do mes.
2. Calcule o saldo final do caixa.
3. Separe as despesas por categoria (Custo fixo, Suprimento, Pessoal,
Equipamento).
4. Identifique qual categoria mais consome o caixa.
5. Mostre os calculos passo a passo, sem pular etapas.
```

O assistente devolve os totais e a análise. Antes de aceitar, confira com uma calculadora — a regra de ouro da bancada: **número que não vem com o cálculo não é número, é chute**.

## Automatizando com Python sem instalar nada

Para quem quer ir além da conversa, a análise pode ser automatizada com Python — e, mais uma vez, sem instalar nada: os assistentes executam Python no navegador, e o Google Colab também roda gratuitamente. O código abaixo lê o CSV, calcula os totais e aponta a categoria que mais pesa no caixa:

```
import pandas as pd

# Leitura dos lançamentos da clinica
df = pd.read_csv("caixa_clinica.csv")

# Totais de entrada e saida
entradas = df["Entrada"].fillna(0).sum()
saidas = df["Saida"].fillna(0).sum()
saldo = entradas - saidas

# Despesas por categoria
despesas = df.groupby("Categoria")
["Saida"].sum().sort_values(ascending=False)

print(f"Entradas do mes: R$ {entradas:,.2f}")
print(f"Saidas do mes: R$ {saidas:,.2f}")
print(f"Saldo do caixa: R$ {saldo:,.2f}")
print("\nDespesas por categoria (maior -> menor):")
print(despesas.to_string())
```

## Classificando despesas com regras (e conferindo com a IA)

Uma das tarefas mais repetitivas da rotina é classificar despesas nas categorias certas. O método em duas etapas funciona assim: primeiro você cria regras simples de classificação, depois pede à IA para aplicar e você confere. Regras típicas de clínica:

```
Classifique cada lançamento pelas regras abaixo e monte uma tabela
Descricao | Categoria:
- Aluguel, condominio, energia, agua, internet -> Custo fixo
- Material de consumo, anestésico, luvas, mascaras -> Suprimento
- Salarios, pro-labore, encargos -> Pessoal
- Manutencao de equipamento, esterilizacao, calibracao -> Equipamento
- Consultas, procedimentos, planos de tratamento -> Procedimento
- Repasses de convenio, operadoras -> Plano
Liste os lançamentos que nao se encaixam em nenhuma regra separadamente.
```

A etapa de conferência é obrigatória: as regras capturam a maioria dos lançamentos, mas a clínica sempre tem exceções — um pagamento de cursos de atualização (que é investimento,

não custo operacional), uma multa (que merece investigação) ou um reembolso. O gestor que confere aprende a enxergar os padrões de gasto da própria clínica; o que não confere importa o viés da ferramenta para dentro do caixa.

## O retrato da sazonalidade do consultório

O fluxo de caixa da odontologia não é uma linha reta — tem sazonalidade. Janeiro costuma ser fraco (retorno de férias e gastos de início de ano), março e agosto têm picos de demanda, e o fim de ano concentra a busca por tratamentos estéticos antes das festas. O dentista gestor que conhece a sazonalidade da própria clínica não se assusta com o janeiro fraco: ele sabe que é o mês de repor material, revisar equipamentos e preparar a campanha de março. O primeiro ano de registros cria essa memória; a partir do segundo, a projeção mensal fica confiável.

## A projeção simples de caixa (90 dias)

Com três meses de dados, a projeção de caixa vira uma planilha simples: entrada esperada (média do mesmo mês do ano anterior, ajustada pelo crescimento), saídas fixas (aluguel, salários, contas) e saídas variáveis (material, manutenção). O assistente de IA monta a projeção com um prompt direto:

Com base nos meus lançamentos dos ultimos 3 meses (coloquei abaixo), projete o fluxo de caixa dos proximos 90 dias considerando: entradas sazonais (janeiro fraco, marco em alta), saidas fixas mensais e uma reserva de 10% para imprevistos. Aponte os dois meses de maior risco de caixa e sugira uma acao preventiva para cada.

## A pergunta de calibração

Antes de confiar na ferramenta para decisões reais, faça a pergunta de calibração — o teste que revela se o assistente calcula ou apenas parece calcular:

Minha clinica faturou R\$ 30.000 no mes e teve R\$ 24.000 de despesas. Qual a margem de lucro? Mostre o calculo completo e depois responda em ate 2 linhas. Se a margem estiver abaixo de 20%, sugira duas alavancas de melhoria.

A resposta correta: margem de 20%  $((30000-24000)/30000)$ . Se o assistente errar esse cálculo simples, ele não está pronto para os seus números reais — use a resposta dele como diagnóstico de calibração e troque de ferramenta ou refine o prompt.



## Montando a rotina do fim de expediente

A disciplina vale mais que a ferramenta. A rotina recomendada é pequena e diária: cinco minutos para registrar os lançamentos do dia (ou pedir para a IA classificar um extrato colado), cinco minutos para conferir o saldo e uma revisão semanal dos indicadores. O objetivo não é perfeição contábil no primeiro mês: é **nunca mais fechar o mês sem saber quanto a clínica ganhou** [2].

## Estruturando sua pasta de trabalho

Crie uma pasta no computador (ou no Google Drive) com o nome `gestao_clinica` e dentro dela quatro arquivos: `caixa_clinica.csv` (os lançamentos diários), `contas_a_pagar.csv` (as contas fixas e seus vencimentos), `pacientes_faturamento.csv` (o valor faturado por paciente, sem dados identificáveis) e `kpis_mensais.csv` (os indicadores de cada mês, que o Capítulo 4 vai usar). Essa estrutura simples é a espinha dorsal de toda a gestão financeira do livro.

## O retrato do investimento inicial

Para dimensionar a importância do fluxo de caixa, vale olhar o investimento que ele precisa proteger. A tabela abaixo reúne as referências de mercado para um consultório básico de uma cadeira — valores indicativos de 2025/2026, que devem ser atualizados na sua região [7]:

| Item                                          | Referência de mercado              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Cadeira odontológica                          | a partir de R\$ 22.650 [7]         |
| Autoclave                                     | a partir de R\$ 6.200 [7]          |
| Compressor                                    | a partir de R\$ 2.700 [7]          |
| Mobiliário, instalações e adequação sanitária | R\$ 10.000–R\$ 30.000 (estimativa) |
| Material inicial e instrumentos               | R\$ 5.000–R\$ 15.000 (estimativa)  |
| <b>Total do consultório básico</b>            | <b>R\$ 40.000–R\$ 100.000 [7]</b>  |

Esse capital precisa ser recuperado pela operação — e é o fluxo de caixa mensal que mostra se a recuperação está acontecendo no prazo planejado. Uma clínica que fatura R\$ 25 mil por mês e retira R\$ 4 mil de pró-labore está recuperando o investimento de R\$ 60 mil a uma velocidade muito diferente da clínica que fatura os mesmos R\$ 25 mil retirando R\$ 10 mil. O gestor precisa ver os dois números todos os meses: quanto a clínica gera e quanto o dono retira.

## O exemplo do pró-labore na prática

O pró-labore não é um conceito vago: é um número decidido com método. O cálculo recomendado para começar: (1) some o que você precisa para viver (moradia, transporte, família, lazer — a sua planilha pessoal); (2) divida por 4,3 semanas para o valor semanal e por 21 dias úteis para o diário; (3) compare com o que a clínica pode pagar sem comprometer o capital de giro (a regra: custos fixos entre 40% e 50% do faturamento, pró-labore incluso na análise). Se o necessário é maior que o possível, o desencontro precisa ser enfrentado cedo — com revisão de preços, de despesas ou de agenda — em vez de virar dívida pessoal no cartão [1][9].

## A pergunta de investigação de gasto

Quando uma despesa chama a atenção no caixa, o gestor não corta no susto — investiga. A pergunta em três níveis: (1) é recorrente ou pontual? (2) é fixa ou varia com a produção? (3) agrega valor ao paciente ou é só custo? Uma manutenção de autoclave de R\$ 450 é pontual e obrigatória; uma assinatura de software que ninguém usa é recorrente e descartável. O assistente de IA ajuda a montar a tabela de investigação:

Organize minha lista de despesas (coladas abaixo) em uma tabela com as colunas: Despesa, Valor mensal, Recorrente ou pontual, Fixa ou variável, Agrega valor ao paciente? (sim/nao). Depois, aponte as tres despesas com maior potencial de reducao sem afetar a qualidade do atendimento.

Esse hábito de investigação é o que separa o corte cego do ajuste cirúrgico — a mesma diferença entre arrancar um dente são e tratar a causa.

## O exemplo da projeção de 90 dias

Para fechar o capítulo com um exemplo completo, acompanhe a projeção de uma clínica de uma cadeira: custo fixo mensal de R\$ 11.000 (aluguel R\$ 4.500, auxiliar R\$ 3.200, energia e contas R\$ 1.300, pró-labore R\$ 2.000), receita média de R\$ 26.000 com sazonalidade (janeiro -30%, março +15%). A projeção de 90 dias mostra que janeiro, o mês mais fraco, ainda cobre os custos fixos com folga de R\$ 4.000 — mas que a compra de material planejada para fevereiro, se juntada a um atraso de convênio, derruba o saldo abaixo de um mês de custo fixo. A decisão preventiva: antecipar a compra de material para dezembro, quando o caixa está no pico. É exatamente esse tipo de antecipação — ver o risco três meses antes — que o fluxo de caixa bem alimentado permite [2][3].

## A frase que resume o capítulo

Se você guardar uma única frase deste capítulo, que seja esta: **o dentista gestor não pergunta quanto entrou, pergunta quanto sobrou e quanto precisa para continuar de pé**. A primeira pergunta se responde no banco; a segunda, no fluxo de caixa; a terceira, no capital de giro [6]. A partir de agora, o seu fim de expediente tem uma nova rotina: cinco minutos, uma planilha, um chat de IA gratuito e a decisão de quem comanda os números — em vez de ser comandado por eles.

## O convite para o próximo expediente

Guarde o exemplo da Dra. Mariana: ela não mudou de paciente, de equipamento ou de cidade — mudou o método. Amanhã, no seu fim de expediente, a rotina começa com dez minutos e um arquivo CSV. O convite deste capítulo é simples: feche o dia de hoje sabendo quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou.

## Kit de verificação do primeiro dia

Ao final deste capítulo, você deve ter: (1) o arquivo `caixa_clinica.csv` com pelo menos dez lançamentos; (2) o cálculo de entradas, saídas e saldo conferido manualmente; (3) a resposta da pergunta de calibração conferida; e (4) a pasta `gestao_clinica` criada com os quatro arquivos. Nada disso exige pagar por software — apenas o assistente gratuito, uma planilha e dez minutos.

## 5. Aplica

---

### A cena do caos

São 21h de uma terça-feira. A Dra. Mariana fecha a agenda de 14 pacientes, passa na recepção e pergunta à auxiliar: “quanto entrou hoje?”. A auxiliar não sabe — o pagamento de uns foi em dinheiro, outros no cartão, um parcelado em três vezes. A Dra. Mariana abre o aplicativo do banco: o saldo da conta da clínica é o mesmo da conta pessoal, porque nunca separou. Ela lembra que a fatura do cartão de material vence amanhã e torce para o dinheiro do convênio cair antes. No fim do mês, a contadora liga para dizer que a clínica “deu prejuízo”, e a Dra. Mariana não consegue explicar por quê — ela trabalhou todos os dias.

## A mesma cena, com o método

Agora imagine a Dra. Mariana uma estação depois. Ela tem o `caixa_clinica.csv` atualizado, o chat de IA aberto e a rotina do fim de expediente funcionando. Às 21h, ela cola o extrato do dia no assistente e pede: “classifique esses lançamentos nas categorias do meu fluxo de caixa”. O assistente devolve a classificação em segundos; ela confere, aceita e olha o saldo. O pró-labore de R\$ 6.000 já foi transferido para a conta pessoal no dia 5. O ticket médio do mês está em R\$ 310, a inadimplência em 4,8% e a margem em 22% — três indicadores na zona saudável, dois deles com tendência de piora que ela já vê na planilha. A decisão sobre a fatura de material deixa de ser torcida e vira escolha: o caixa cobre, e o capital de giro está em dois meses de custo fixo.

## Exercício do fim de expediente

1. Liste as três despesas fixas da sua clínica (ou da clínica que você vai montar) e seus valores mensais.
2. Calcule o ticket médio do último mês:  $\text{faturamento} \div \text{pacientes atendidos}$ . Se você não tem o número, estime com os dados que tiver.
3. Abra o assistente de IA gratuito e peça: “monte uma planilha de fluxo de caixa para uma clínica odontológica com as colunas Data, Descrição, Categoria, Entrada, Saída e as categorias Procedimento, Plano, Custo fixo, Suprimento, Pessoal, Equipamento. Explique cada coluna.”.
4. Escreva em uma frase qual é o seu pró-labore mensal — se você não tem um, esse é o seu primeiro projeto do livro.

## O exercício corrige o rumo

Se você fez o exercício, já percebeu a primeira virada de mentalidade: o dentista gestor não pergunta “quanto entrou hoje?”, pergunta “qual é o meu fluxo e qual é a minha margem?”. A segunda pergunta é muito mais difícil de responder no chute — e muito mais fácil de responder com uma planilha e um assistente de IA gratuitos.

## 6. Conclusão

---

Neste capítulo, você viu por que a gestão financeira é o ponto cego da formação odontológica e por que isso custa caro: clínicas fecham não por falta de pacientes, mas por falta de controle [1]. Você conheceu os números que resumem a saúde de um consultório — ticket médio, margem líquida, inadimplência, pró-labore e capital de giro [5][6][8] — e o custo real de montar a

estrutura [3][4]. E você deu o primeiro passo prático: o arquivo de fluxo de caixa, a pergunta de calibração e a rotina do fim de expediente.

O próximo capítulo aprofunda os números da clínica: você vai aprender a ler o fluxo de caixa, a construir um DRE simplificado e a calcular o ticket médio com dados reais do setor — sempre com a IA gratuita na bancada.

## 7. Referências

---

- [1] Purcino, G. A. J. et al. A importância da gestão financeira e plano de negócios em clínicas e consultórios odontológicos. E-Acadêmica, 2022. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/176>. Acesso em: 08 ago. 2026. [2] Brasil, F. P. et al. Processos de administração financeira em consultórios odontológicos. Revista Fatec Zona Sul (Refas), 2023. Disponível em: <https://www.revistarefas.com.br/RevFATECZS/article/view/634>. Acesso em: 08 ago. 2026. [3] Gnatus. Guia de equipamentos odontológicos essenciais para começar. 2025. Disponível em: <https://www.gnatus.com.br/blog/guia-equipamentos-odontologicos-consultorio/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [4] Costa, R. M. et al. Odontoclínica: simulação de gestão em clínica odontológica em um curso de Graduação em Odontologia. Revista da ABENO, 2015. Disponível em: [https://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1679-59542015000100010](https://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-59542015000100010). Acesso em: 08 ago. 2026. [5] Odontiva. 10 KPIs Essenciais para Clínica Odontológica. 2026. Disponível em: <https://odontiva.com.br/blog/indicadores-desempenho-clinica-odontologica>. Acesso em: 08 ago. 2026. [6] Dental Office. Dentista: como calcular o ticket médio da sua clínica odontológica? 2024. Disponível em: <https://www.dentaloffice.com.br/ticket-medio/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [7] Clinicorp. Como calcular o ticket médio na odontologia? Aprenda agora. 2025. Disponível em: <https://www.clinicorp.com/post/calcular-ticket-medio-odontologia>. Acesso em: 08 ago. 2026. [8] Sanders, L. Como funciona a margem de lucro na odontologia? Simples Dental, 2025. Disponível em: <https://www.simplesdental.com/blog/margem-de-lucro-na-odontologia/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [9] CROSP/Sebrae. 41º CIOSP: Planejamento financeiro de clínicas odontológicas foi tema de palestra do Sebrae. São Paulo: CROSP, 2024. Disponível em: <https://crops.org.br/noticia/41-ciosp-planejamento-financeiro-de-clinicas-odontologicas-foi-tema-de-palestra-do-sebrae/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [10] Angelus. Como ter uma boa gestão financeira do consultório odontológico? 2024. Disponível em: <https://angelus.ind.br/pt-br/blog/gestao-financeira-de-consultorio-odontologico/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [11] Ministério da Saúde/DATASUS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [12] Ministério da Saúde. LGPD no setor saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 08 ago. 2026. [13] ANPD. Regulamentações — Resoluções de proteção de dados. Disponível em: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes\\_anpd](https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd). Acesso em: 08 ago. 2026. [14] Conselho Federal de Odontologia. Portal

institucional — normas e resoluções da profissão. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [15] Ministério da Saúde/IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/julho/ministerio-da-saude-e-ibge-iniciam-terceira-edicao-da-pesquisa-nacional-de-saude>. Acesso em: 08 ago. 2026.

## Capítulo 2: Os Números da Clínica — Fluxo de Caixa, Ticket Médio e Custos

---

### 1. Introdução

---

No capítulo anterior, você criou o primeiro arquivo de fluxo de caixa e aprendeu a rotina do fim de expediente. Agora é hora de dar profundidade: entender de onde vêm os números, como eles se organizam e o que cada um deles diz sobre a clínica. Um dentista gestor não é um contador — ele não precisa fechar balanços, mas precisa **ler** os números com a mesma segurança com que lê uma radiografia.

Este capítulo ensina três instrumentos de leitura financeira na medida certa para uma clínica odontológica: o **fluxo de caixa** (o pulso diário do dinheiro), o **DRE simplificado** (a radiografia mensal do resultado) e o **ticket médio** (o termômetro do valor que cada paciente agrega). Você vai aprender a montá-los com planilha e IA gratuita, a interpretar os padrões de mercado do setor — custos fixos entre 40% e 50% do faturamento, margem líquida entre 20% e 35%, inadimplência abaixo de 5% [3] — e a cruzar seus números com referências macroeconômicas oficiais para decidir com mais segurança.

Ao final, você saberá responder três perguntas que o banco, o sócio e o seu futuro eu vão fazer: quanto a clínica movimenta, quanto ela custa para ficar de pé e quanto cada atendimento vale de verdade.

### 2. Explica

---

#### O fluxo de caixa: o pulso diário

O fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro da clínica, organizado por data. Ele responde à pergunta mais imediata da gestão: **quanto dinheiro existe hoje para pagar as contas de hoje?** A literatura de administração de consultórios recomenda estruturar

esse controle com lançamentos sistemáticos — nada de confiar na memória ou no extrato do banco pessoal [1]. Cada lançamento tem quatro informações: data, descrição, categoria e valor (entrada ou saída).

A diferença entre fluxo de caixa e lucro é crucial e confunde a maioria dos dentistas. O fluxo de caixa enxerga o dinheiro que **entrou e saiu**; o lucro é uma visão contábil que considera receitas e despesas **incorridas**, independentemente de pagamento. Um paciente pode ter feito um tratamento de R\$ 4.800 parcelado em dez vezes: o fluxo de caixa registra R\$ 480 por mês, enquanto o DRE reconheceria o valor do procedimento no mês da entrega. O gestor precisa das duas visões — o caixa para não quebrar, o resultado para saber se está ganhando [1].

### O capital de giro: o colchão da clínica

Se o fluxo de caixa é o pulso, o capital de giro é o oxigênio. Ele é calculado como a diferença entre o ativo circulante (o que a clínica tem em caixa, banco e contas a receber de curto prazo) e o passivo circulante operacional (o que ela deve no curto prazo: fornecedores, impostos, salários) [2]. Um consultório que recebe dos planos odontológicos com 45 a 60 dias de prazo, mas paga material e salários todo mês, precisa de capital de giro suficiente para atravessar esse intervalo sem parar de respirar [2].

A regra prática para clínicas pequenas: mantenha capital de giro de pelo menos um a dois meses de custo fixo. Se os custos fixos mensais somam R\$ 15.000, o colchão deve ficar entre R\$ 15 mil e R\$ 30 mil. Abaixo disso, qualquer atraso de convênio vira emergência — e emergência financeira em clínica quase sempre termina em desconto, parcelamento forçado ou empréstimo caro.

### O DRE simplificado: a radiografia mensal

O Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) é o documento que mostra, linha a linha, como a receita se transforma em lucro. A versão simplificada para clínicas tem cinco blocos: **receita bruta** (tudo o que foi faturado no mês), **deduções** (impostos e descontos), **receita líquida**, **custos e despesas** (fixos, variáveis, pessoal, impostos) e **resultado** (lucro ou prejuízo). Cada bloco responde a uma pergunta de gestão: quanto faturou, quanto sobrou depois dos impostos, quanto custou para operar e quanto ficou de resultado [3].

Os padrões de mercado ajudam a ler o DRE da odontologia: os custos fixos devem ficar entre 40% e 50% do faturamento bruto, e a margem de lucro líquida saudável está entre 20% e 35% [3][6]. Quando a margem fica abaixo de 20%, o problema quase sempre está em um de três lugares: precificação (procedimentos subvalorizados), desconto excessivo (pacientes acostumados a negociar) ou custos fora de controle (gastos que cresceram sem revisão) [6].



## O ticket médio: o termômetro do valor

O ticket médio é o faturamento total dividido pelo número de pacientes atendidos em um período [4][5]. É o indicador mais rápido de dizer se a clínica está **vendendo tratamento ou vendendo tempo**. Um ticket médio de R\$ 150 indica predominância de consultas e limpezas; um de R\$ 400 indica mix de tratamentos de maior valor (implantes, próteses, ortodontia) [4]. O indicador também expõe a política de preços: desconto demais e parcelamento longo arrastam o ticket para baixo, mesmo com agenda cheia [5].

A leitura do ticket médio nunca deve ser isolada. O gestor cruza o ticket com o volume de pacientes e com a ocupação da agenda: um ticket alto com poucos pacientes pode significar preço acima do mercado; um ticket baixo com muitos pacientes pode significar operação de volume sem margem. O equilíbrio é o ponto em que a clínica maximiza o resultado por cadeira — e é para isso que o Capítulo 4 vai montar o painel de comando [3].

## O custo da cadeira e a depreciação

Um erro comum em clínicas é ignorar o custo dos equipamentos na hora de precificar. A cadeira odontológica parte de R\$ 22.650, a autoclave de R\$ 6.200 e o compressor de R\$ 2.700 [7]; somando o restante da infraestrutura, o investimento inicial fica entre R\$ 40 mil e R\$ 100 mil [7]. Esse capital investido não é despesa de um mês: ele se transforma em **depreciação**, o custo de uso do equipamento distribuído ao longo da sua vida útil. Uma cadeira de R\$ 30.000 com vida útil de 10 anos custa R\$ 3.000 por ano, ou R\$ 250 por mês, para a clínica — um custo que existe mesmo quando a cadeira está vazia [7].

Por isso, o custo unitário por sessão — quanto custa, de verdade, abrir a cadeira para um paciente — é uma conta que combina custos fixos rateados, custos variáveis de material e depreciação de equipamento. Dentistas que fazem essa conta descobrem que o “preço de mercado” da limpeza muitas vezes está abaixo do custo real da clínica [8]. É a origem do fenômeno: quanto mais pacientes de procedimento barato, mais rápido o caixa afunda.

## O pró-labore e a separação das contas

O pró-labore é o salário que o dentista define para si como gestor — e a regra do setor é enfática: sem pró-labore definido, não há gestão [9]. O dinheiro da clínica e o dinheiro da família devem viver em contas separadas, e o dentista deve se pagar todo mês, como paga a auxiliar. O que sobra depois do pró-labore é o resultado do negócio — e é esse resultado que decide reinvestimento, reserva e crescimento [9].

## O contexto externo: juros, inflação e o mercado de serviços

A clínica não opera em uma bolha: a taxa de juros define o custo de um empréstimo para equipar uma terceira cadeira, a inflação corrige o aluguel e os preços de material, e o setor de serviços como um todo dá o parâmetro de crescimento da receita. Essas referências têm fontes oficiais gratuitas: o Banco Central publica séries históricas de juros, inflação e crédito no Sistema Gerenciador de Séries Temporais [10], com dados abertos em formato estruturado para planilhas e ferramentas de análise [11]; o IBGE acompanha mensalmente a receita do setor de serviços na Pesquisa Mensal de Serviços, um benchmark para comparar o faturamento da clínica com o do mercado [12]. Com essas séries, o gestor pode responder, por exemplo: “se a Selic subiu 1 ponto, quanto o meu custo de crédito muda?” — sem depender de achismo [10][11].

## A disciplina da apuração mensal

O que transforma esses instrumentos em gestão real é a rotina: apurar o DRE todo mês, no mesmo dia, com os mesmos critérios. Estudos sobre a mortalidade de clínicas apontam o controle mensal de despesas, custos e fluxo de caixa como o principal fator que separa as clínicas que sobrevivem das que fecham [13]. A IA gratuita não elimina a disciplina — ela torna a disciplina barata: classificar lançamentos, montar o DRE e comparar meses leva minutos com um assistente na bancada.

## 3. Ilustra

O prontuário financeiro da clínica é como um dossiê de exames: cada documento olha para uma dimensão diferente do mesmo paciente — o negócio. O fluxo de caixa é o eletrocardiograma (bate a cada dia), o DRE é a radiografia (revela a estrutura do mês), o ticket médio é o termômetro (mede o valor do atendimento) e o capital de giro é a reserva de oxigênio.

Como Gestor de Clínica Odontológica, você vai olhar para o prontuário financeiro todas as semanas. O diagrama abaixo mostra como os três instrumentos se alimentam dos mesmos dados e convergem para a decisão.

```
%% legenda: Instrumentos de leitura financeira da clinica
flowchart TB
    A[Lancamentos diarios] --> B[Fluxo de caixa]
    A --> C[Faturamento por paciente]
    B --> D[DRE simplificado]
    C --> E[Ticket medio]
    D --> F{Resultado do mes}
    E --> G{Margem e valor}
    F --> H[Dashboard de comandos]
```

```
G --> H
H --> I[Decisoes: precos, custos, investimento]
I --> J[Pro-labore, capital de giro, reinvestimento]
```

## 4. Técnica

### Montando o DRE simplificado na planilha

Com o arquivo `caixa_clinica.csv` do capítulo anterior, o próximo passo é estruturar o DRE mensal. A forma mais rápida é pedir ao assistente de IA que monte a planilha a partir da sua descrição:

```
Monte uma planilha de DRE simplificado para uma clinica odontologica
com as seguintes linhas e formulas:
1. Receita bruta (soma das entradas de Procedimento e Plano).
2. Deducoes: 8% de impostos sobre a receita bruta (simulacao de Simples
Nacional).
3. Receita liquida = Receita bruta - Deducoes.
4. Custos variaveis (Suprimento).
5. Custos fixos (Custo fixo + Pessoal + Equipamento).
6. Resultado = Receita liquida - Custos variaveis - Custos fixos.
7. Margem = Resultado / Receita liquida, em percentual.
Explique cada linha em uma frase.
```

### Automatizando a apuração com Python

Para apurar o DRE e o ticket médio sem digitar nada, use o código abaixo (roda no assistente ou no Google Colab):

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("caixa_clinica.csv")

# Receita bruta: procedimentos + planos
receita_bruta = df[df["Categoria"].isin(["Procedimento", "Plano"])]
["Entrada"].fillna(0).sum()

# Custos
custos_variaveis = df[df["Categoria"] == "Suprimento"]
```

```

["Saida"].fillna(0).sum()
custos_fixos = df[df["Categoria"].isin(["Custo fixo", "Pessoal",
"Equipamento"])]["Saida"].fillna(0).sum()

# DRE simplificado
deducoes = receita_bruta * 0.08
receita_liquida = receita_bruta - deducoes
resultado = receita_liquida - custos_variaveis - custos_fixos
margem = (resultado / receita_liquida) * 100 if receita_liquida else 0

print("=== DRE SIMPLIFICADO ===")
print(f"Receita bruta:      R$ {receita_bruta:,.2f}")
print(f"Deducoes (8%):      R$ {deducoes:,.2f}")
print(f"Receita liquida:     R$ {receita_liquida:,.2f}")
print(f"Custos variaveis:    R$ {custos_variaveis:,.2f}")
print(f"Custos fixos:       R$ {custos_fixos:,.2f}")
print(f"Resultado:          R$ {resultado:,.2f}")
print(f"Margem:              {margem:.1f}%")

# Ticket medio (faturamento por paciente - arquivo sem dados
identificaveis)
pacientes = pd.read_csv("pacientes_faturamento.csv")
ticket = pacientes["Valor"].sum() / len(pacientes) if len(pacientes) else 0
print(f"\nTicket medio:      R$ {ticket:,.2f} por paciente")

```

## Cruzando com referências oficiais

Para comparar a sua margem com o comportamento do mercado de serviços, baixe a série de receita do setor na Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE [12] e a série de juros no SGS do Banco Central [10]. O exercício de benchmarking é simples:

Tenho os dados da minha clinica: margem de X%, custos fixos de Y% da receita, ticket medio de R\$ Z. Compare com os padroes de mercado do setor odontologico (custos fixos 40-50%, margem 20-35%, inadimplencia <5%) e com a evolucao da receita do setor de servicos no IBGE. Aponte os tres desvios mais relevantes e uma acao para cada um.

## A planilha de custos da cadeira

Monte a conta do custo real por sessão — o número que quase nenhuma clínica conhece:

```
import pandas as pd
```

```
# Custos fixos mensais rateados por cadeira
custos = pd.read_csv("contas_a_pagar.csv")
custo_fixo_mensal = custos["Valor"].sum()
numero_cadeiras = 2
sessoes_por_cadeira_mes = 160

# Depreciacao da cadeira (R$ 30.000, 10 anos)
depreciacao_mensal_cadeira = 30000 / 120

custo_por_sessao = (custo_fixo_mensal / (numero_cadeiras *
                                         sessoes_por_cadeira_mes)
                   + depreciacao_mensal_cadeira / sessoes_por_cadeira_mes)
print(f"Custo fixo por sessao: R$ {custo_por_sessao:,.2f}")
print("(some o material de cada procedimento para o custo total)")
```

### A análise de sensibilidade: o que acontece se...

O DRE não responde sozinho às perguntas de gestão; ele responde quando o gestor mexe nas alavancas. A análise de sensibilidade testa cenários: o que acontece com o resultado se o ticket médio subir 10%? Se a inadimplência cair de 8% para 4%? Se o aluguel subir 15% na renovação? O método em planilha é simples: premissas em células separadas (nunca embutidas em fórmulas) e uma aba de cenários que referencia essas células.

Na minha planilha de DRE, crie uma aba de cenários com tres colunas: Realista (premissas atuais), Otimista (ticket medio +10%, inadimplencia -2 pontos, custos fixos -3%) e Pessimista (ticket medio -8%, inadimplencia +3 pontos, custos fixos +5%). Referencie sempre as celulas de premissa da aba principal – nunca valores fixos. Explique como navegar entre os cenarios e qual deles devo usar como base para o planejamento mensal.

A análise de sensibilidade muda a conversa com o sócio e com o banco: em vez de “a clínica vai bem”, o gestor diz “no cenário realista, a margem fica em 24%; no pessimista, em 16% — e a alavanca que mais protege é reduzir a inadimplência”. Número com cenário é decisão; número sem cenário é opinião.

### O benchmark com o setor de serviços

Para saber se o crescimento da clínica está acima ou abaixo do mercado, o gestor usa a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE [12]: a variação acumulada da receita do setor é a régua externa. O método é simples: a cada trimestre, comparar o crescimento da receita da clínica com o crescimento do setor no mesmo período. Clínica crescendo abaixo do setor com margem caindo é sinal de problema interno; crescendo abaixo do setor com margem estável pode ser escolha (menos volume, mais valor). O benchmark não decide — ele informa a pergunta certa.

## A tabela de referência do setor

Para fixar os padrões, a tabela abaixo resume as referências de mercado discutidas neste capítulo — guarde-a ao lado do painel:

| Indicador                        | Referência saudável     | O que indica desvio                             |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Custos fixos / faturamento bruto | 40%–50%                 | acima: estrutura pesada ou preço baixo [3]      |
| Margem líquida                   | 20%–35%                 | abaixo de 20%: preço, desconto ou custo [6]     |
| Inadimplência                    | abaixo de 5%            | acima de 10%: ação imediata de cobrança [3]     |
| Ticket médio                     | depende do mix          | em queda: mix de baixo valor ou desconto [4][5] |
| Capital de giro                  | 1–2 meses de custo fixo | abaixo: risco de caixa [2]                      |

## O DRE de exemplo, número por número

Para fixar a leitura, acompanhe um DRE completo de uma clínica fictícia de uma cadeira. No mês, a clínica faturou R\$ 32.000 em procedimentos e R\$ 8.000 em repasses de plano — receita bruta de R\$ 40.000. Aplicando 8% de deduções simuladas (faixa baixa do Simples Nacional para serviços), a receita líquida fica em R\$ 36.800. Os custos: R\$ 3.200 de material (suprimento), R\$ 9.000 de salários e encargos da auxiliar, R\$ 6.500 de aluguel e condomínio, R\$ 1.800 de energia e despesas fixas, R\$ 1.200 de manutenção e esterilização, R\$ 900 de pró-labore da recepção terceirizada — total de despesas de R\$ 22.600. Resultado: R\$ 14.200, uma margem líquida de 38,6%. Parece excelente — até o gestor lembrar que ainda precisa pagar o próprio pró-labore de R\$ 8.000 e que a depreciação da cadeira (R\$ 250/mês) não está contabilizada. Ajustado, o resultado real é R\$ 5.950, margem de 16,2% — dentro do amarelo, não do verde. O DRE só conta a história completa quando todas as camadas entram: impostos, depreciação e pró-labore [3][6].

## As perguntas que o DRE responde (e as que ele não responde)

O DRE responde: a clínica está ganhando ou perdendo no mês? Qual fatia da receita vai para impostos, custos e despesas? Qual é a margem real? O DRE não responde: quanto dinheiro existe no caixa hoje (isso é fluxo de caixa), qual paciente não pagou (isso é contas a receber), nem se os equipamentos estão sendo usados (isso é ocupação e receita por cadeira). O gestor que mistura os papéis — usar DRE para decidir caixa, ou caixa para decidir margem — toma decisões erradas

com documentos certos. A disciplina do prontuário financeiro é usar cada exame para o que ele serve [1][2].

### A leitura de tendência: três meses valem mais que um

Um mês isolado é ruído; três meses são sinal. O gestor não decide com base no DRE de um mês — ele olha a tendência: o resultado está subindo, caindo ou estável? O método é simples: montar a tabela de três meses (receita, custos, resultado, margem, ticket, inadimplência) e pedir à IA a leitura:

Compare os tres ultimos meses da minha clinica (tabela abaixo). Para cada indicador, diga se a tendencia e de alta, queda ou estabilidade, quantifique a variacao em percentual e aponte o mes que destoa. Finalize com uma frase: a clinica esta em expansao, estabilidade ou retracao? Justifique com os numeros.

A tendência de três meses também protege contra a reação exagerada: um mês fraco por motivo sazonal (janeiro) não vira pânico, e um mês bom por evento pontual (plano de tratamento fechado) não vira euforia. O prontuário financeiro — como o clínico — acompanha o caso ao longo do tempo, não em uma única foto [1][3].

### Precificando com o custo na mão

A precificação baseada no custo — e não no “preço do concorrente” — é uma das maiores viradas deste capítulo. O método em quatro passos: (1) calcule o custo total do procedimento (material + tempo de cadeira + custo fixo rateado por sessão + depreciação); (2) defina a margem-alvo (entre 20% e 35% para o mix saudável [6]); (3) derive o preço mínimo ( $\text{custo} \div (1 - \text{margem-alvo})$ ); (4) compare com o preço de mercado e decida conscientemente: cobrar acima do mínimo financia qualidade e reserva; cobrar abaixo é escolha de captação, desde que o gestor saiba exatamente quanto está sacrificando. O assistente de IA monta a conta:

Calcule o preco minimo de venda de um procedimento com: material R\$ 45, tempo de cadeira 40 minutos (custo da hora da clinica: R\$ 180, incluindo auxiliar, aluguel, energia e depreciacao), e margem-alvo de 25%. Mostre o calculo passo a passo e o preco arredondado para valores comerciais. Depois, compare com um preco de mercado de R\$ 280 e explique o que essa diferenca significa para a margem.

O dentista que precifica com o custo na mão negocia de igual para igual com convênios e planos — e sabe, antes de aceitar um desconto, quanto ele custa em margem [6].

## O que evitar no prontuário financeiro

Três armadilhas repetem-se nas clínicas e valem um aviso: (1) **misturar contas** — pessoa física e jurídica no mesmo cartão ou conta corrente inviabiliza qualquer leitura; (2) **precificar sem custo** — o preço baseado no concorrente ignora a estrutura da própria clínica; (3) **medir um mês só** — decisões tomadas com um mês isolado oscilam com a sazonalidade. O prontuário financeiro saudável evita as três: contas separadas, preço derivado do custo e leitura de tendência de três meses [1][3][6].

## A memória de doze meses

Ao completar doze meses de prontuário financeiro, o gestor ganha o ativo mais valioso da gestão: a memória do próprio negócio. Com um ano de dados, ele sabe o pico de demanda de março, a fraqueza de janeiro, o comportamento dos convênios e o custo real de cada procedimento — e pode planejar o ano seguinte com números, não com intuição. A IA transforma essa memória em projeção e cenários; o dentista transforma a projeção em decisão.

## Kit de verificação do capítulo

Ao final, você deve ter: (1) o DRE do mês apurado e conferido; (2) o ticket médio calculado e comparado com o padrão do setor; (3) o custo por sessão estimado; e (4) uma referência oficial (BCB ou IBGE) anotada no arquivo `kpis_mensais.csv`.

## 5. Aplica

---

### A cena do caos

O Dr. Carlos tem agenda cheia há três anos. Ele fatura R\$ 45 mil por mês, mas toda vez que precisa trocar um equipamento, precisa “quebrar o galho” — descontar uma fatura no cartão ou pedir ajuda à família. A contadora diz que a clínica é “saudável”, porque o DRE do escritório mostra lucro. O Dr. Carlos não entende por que, com lucro contábil, falta dinheiro no caixa. Ele descobre a resposta no dia em que o convênio atrasa dois repasses: a clínica não tem capital de giro, e o “lucro” contábil está preso em parcelamentos de pacientes que ainda não entraram no caixa.



## A mesma cena, com o método

Com fluxo de caixa, DRE e ticket médio na mesa, o diagnóstico aparece em dez minutos. O faturamento de R\$ 45 mil tem R\$ 12 mil presos em parcelas a receber. Os custos fixos somam R\$ 21 mil — 47% do faturamento bruto, dentro do padrão, mas no limite. O ticket médio é R\$ 180, abaixo da meta de R\$ 250. O Dr. Carlos toma duas decisões com os dados na mão: cria uma reserva de capital de giro (R\$ 21 mil = um mês de custo fixo) transferindo 10% da receita mensal, e relança o plano de tratamento com precificação revisada, que ele agora consegue justificar com o custo por sessão. Seis meses depois, o ticket médio está em R\$ 235, a reserva montada e a troca de equipamento vira decisão de caixa, não emergência.

## Exercício do prontuário financeiro

1. Calcule o seu ticket médio dos últimos três meses e compare com o padrão do setor.
2. Monte o DRE do mês (receita bruta, deduções, custos, resultado, margem) na planilha.
3. Calcule o custo por sessão da sua cadeira.
4. Responda com o assistente de IA: “qual a minha necessidade de capital de giro se meu custo fixo mensal é R\$ X e meus recebimentos de convênio levam 45 dias?”.
5. Registre tudo no `kpis_mensais.csv` — o Capítulo 4 vai transformar esses números em um painel.

## O exercício corrige o rumo

A virada deste capítulo é a mudança de pergunta: o dentista gestor não pergunta mais “deu lucro?”, pergunta “deu caixa e deu margem?”. As duas respostas juntas — caixa positivo e margem acima de 20% — são o sinal de que a clínica está viva e crescendo [3][6].

## 6. Conclusão

---

Você aprendeu a ler o prontuário financeiro da clínica: o fluxo de caixa como pulso diário [1], o capital de giro como oxigênio [2], o DRE como radiografia mensal [3], o ticket médio como termômetro do valor [4][5] e o custo por sessão como a régua da precificação [7][8]. Você também aprendeu a cruzar os seus números com referências oficiais — juros e crédito no Banco Central [10][11] e o comportamento do setor de serviços no IBGE [12] — e a manter a disciplina da apuração mensal, o fator que a literatura associa à sobrevivência das clínicas [13].

O próximo capítulo coloca a IA gratuita no centro da bancada: você vai aprender a usar modelos gratuitos e planilhas para montar esses controles com prompts eficazes — sem digitar fórmula nenhuma.

## 7. Referências

---

- [1] Brasil, F. P. et al. Processos de administração financeira em consultórios odontológicos. Revista Fatec Zona Sul (Refas), 2023. Disponível em: <https://www.revistarefas.com.br/RevFATECZS/article/view/634>. Acesso em: 08 ago. 2026. [2] Angelus. Como ter uma boa gestão financeira do consultório odontológico? 2024. Disponível em: <https://angelus.ind.br/pt-br/blog/gestao-financeira-de-consultorio-odontologico/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [3] Odontiva. 10 KPIs Essenciais para Clínica Odontológica. 2026. Disponível em: <https://odontiva.com.br/blog/indicadores-desempenho-clinica-odontologica>. Acesso em: 08 ago. 2026. [4] Dental Office. Dentista: como calcular o ticket médio da sua clínica odontológica? 2024. Disponível em: <https://www.dentaloffice.com.br/ticket-medio/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [5] Clinicorp. Como calcular o ticket médio na odontologia? Aprenda agora. 2025. Disponível em: <https://www.clinicorp.com/post/calcular-ticket-medio-odontologia>. Acesso em: 08 ago. 2026. [6] Sanders, L. Como funciona a margem de lucro na odontologia? Simples Dental, 2025. Disponível em: <https://www.simplesdental.com/blog/margem-de-lucro-na-odontologia/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [7] Gnatus. Guia de equipamentos odontológicos essenciais para começar. 2025. Disponível em: <https://www.gnatus.com.br/blog/guia-equipamentos-odontologicos-consultorio/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [8] Costa, R. M. et al. Odontoclínica: simulação de gestão em clínica odontológica em um curso de Graduação em Odontologia. Revista da ABENO, 2015. Disponível em: [https://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1679-59542015000100010](https://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-59542015000100010). Acesso em: 08 ago. 2026. [9] CROSP/Sebrae. 41º CIOSP: Planejamento financeiro de clínicas odontológicas foi tema de palestra do Sebrae. São Paulo: CROSP, 2024. Disponível em: <https://crops.org.br/noticia/41-ciosp-planejamento-financeiro-de-clinicas-odontologicas-foi-tema-de-palestra-do-sebrae/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [10] Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [11] Banco Central do Brasil. Dados Abertos — Séries estatísticas de crédito e serviços. Disponível em: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [12] IBGE. Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/servicos/9229-pesquisa-mensal-de-servicos.html>. Acesso em: 08 ago. 2026. [13] Purcino, G. A. J. et al. A importância da gestão financeira e plano de negócios em clínicas e consultórios odontológicos. E-Acadêmica, 2022. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/176>. Acesso em: 08 ago. 2026.

## Seu próximo passo

---

Este e-book é um recorte de **O Dentista Gestor: Finanças de Clínica com IA** — a obra completa traz os 4 capítulos com teoria aprofundada, todos os códigos executáveis, os diagramas e as referências oficiais (CROSP/Sebrae, CFO, Banco Central, IBGE, LGPD e ANPD).

**Quero a obra completa** — [https://seu-site.com.br/ia?utm\\_source=ebook&utm\\_medium=epub&utm\\_campaign=dentista-gestor](https://seu-site.com.br/ia?utm_source=ebook&utm_medium=epub&utm_campaign=dentista-gestor)

**O seu fim de expediente nunca mais será o mesmo — uma planilha, um chat de IA gratuito e a decisão de quem comanda os números.**

